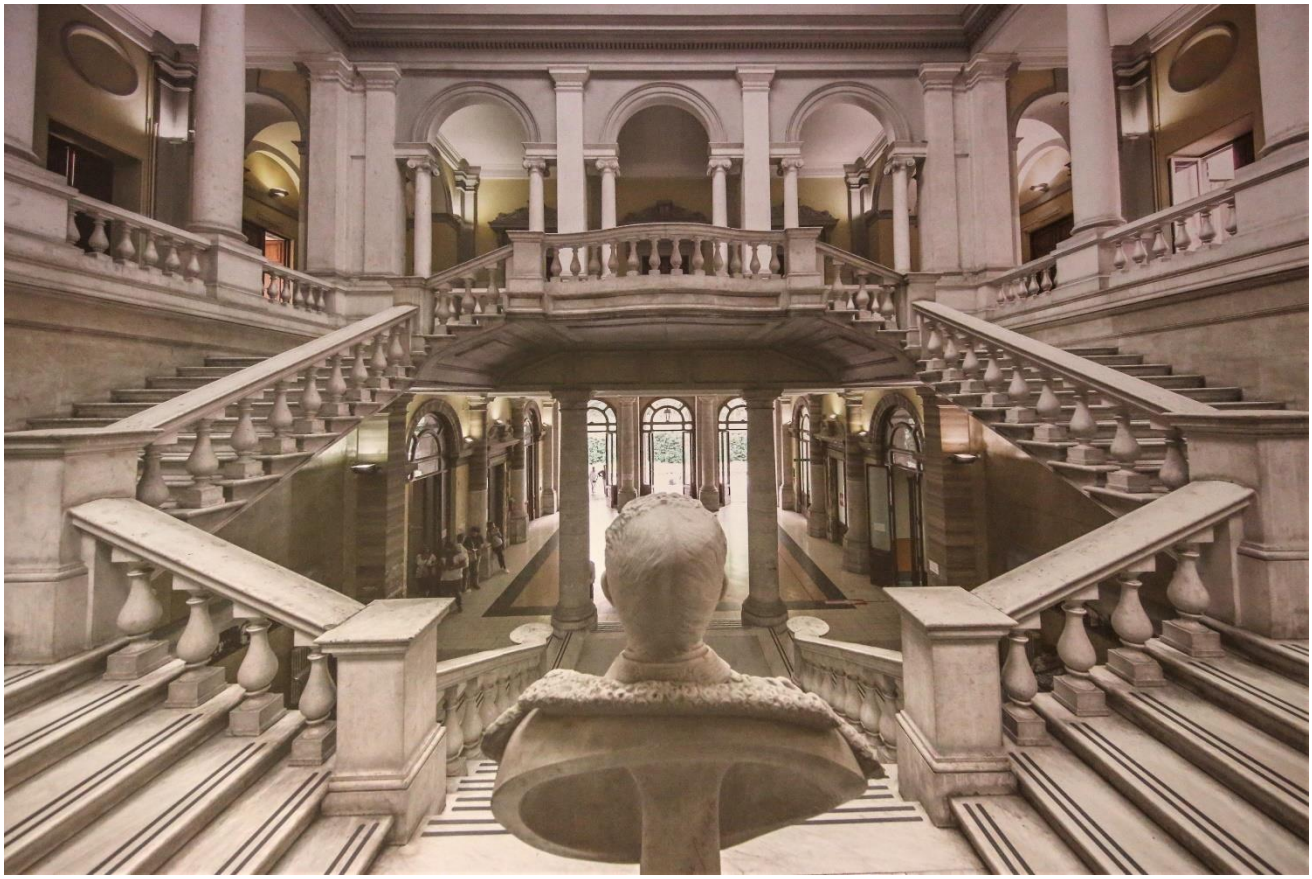
CARTA *dei* SERVIZI

Guida pratica per il Cittadino

2025-2026

www.policlinicoumberto1.it



Guida pratica del Cittadino
A cura: Comunicazione-URP e Ufficio STAMPA
Responsabile dott.ssa Manuela Astrologo
Redazione: dott.ssa Roberta Bizzochi

La stesura delle informazioni è aggiornata al 31 Dicembre 2025

SOMMARIO

L'AZIENDA: IDENTITA', MISSIONE E VALORI 7
ISTITUZIONE E CENNI STORICI 7
SEDE, LOGO E SITO INTERNET 8
PATRIMONIO AZIENDALE 8
MISSIONE 8
VALORI 9
VISIONE 11
ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI, ORGANISMI E COMITATI 12
GLI ORGANI DELL'AZIENDA 12
IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Fabrizio d'Alba 12
L'ORGANO DI INDIRIZZO 13
IL COLLEGIO SINDACALE 13
IL COLLEGIO DI DIREZIONE 14
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 14
GLI ORGANISMI, I COMITATI, LE COMMISSIONI 15
IL CONSIGLIO DEI SANITARI 15
L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 15
IL COMITATO ETICO 15
IL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA) 16
IL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 16
IL COMITATO BUON USO DEL SANGUE (COBUS) 17
IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONEDEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 18
IL COMITATO PER L'OSPEDALE SENZA DOLORE 19
LA COMMISSIONE PER IL PRONTUARIO TERAPEUTICO (CPTO) 19
IL COMITATO DEI GARANTI 19
ASSETTO ORGANIZZATIVO 21
I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA 21
L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) 22
IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI 22
IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 22
SISTEMA DEI CONTROLLI 23
STRUMENTI DI TUTELA DEI CITTADINI 24
PRINCIPI GENERALI 24
L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 24
IL PROCESSO DI AUDIT CIVICO 24
LA CARTA DEI SERVIZI 25
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI PAZIENTI 25
STRUMENTI DI GOVERNO CLINICO 25
LE RETI INTERAZIENDALI 26
Area Emergenza 26
Area Cronicità e Malattie Rare 26
Area Trapianti d'Organo 26

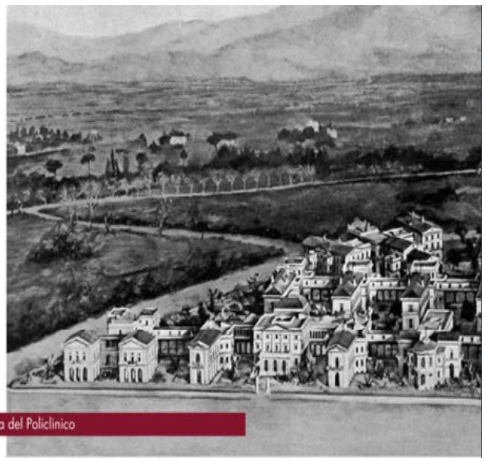
Rete Oncologica 26
I PERCORSI CLINICI, I PDTA E LE *UNIT* 27
PERCORSI CLINICI 27
L'UNITA' DI DEGENZA A GESTIONE INFERMIERISTICA (UDI) 28
UOSD RICERCA CLINICA E CLINICAL COMPETENCE (URCCC) 29
SERVIZI AL CITTADINO 29
PRONTO SOCCORSO 29
RICOVERO 30
DIMISSIONE PROTETTA 30
L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) 31
BOLLINO ROSA 31
BOLLINO AZZURRO 31
ASPETTI ALBERGHIERI E COMFORT 31
COSA FARE PER 32
AVERE INFORMAZIONI 32
APP POLICLINICO UMBERTO I 32
URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 32
SEGNALARE RECLAMI, DISSERVIZI, ENCOMI 33
UFFICIO STRANIERI 33
RILASCIO PERMESSI VEICOLI - MOBILITY MANAGER/MOBILITÀ 33
PRENOTAZIONI 33
PAGAMENTI E REGISTRAZIONI TICKET - PAGAMENTI E REGISTRAZIONI TICKET - POLICLINICO UMBERTO 1 34
L'APP del Policlinico Umberto I 34
RICHIEDERE/RITIRARE LA CARTELLA CLINICA 34
Cartella clinica e documentazione sanitaria - Policlinico Umberto 1 Dove richiederla 34
Come richiederla 35
Contatti: 35
Tariffa duplicazione immagini: 35
DICHIARARE LA NASCITA 36
DONARE SANGUE ED EMOCOMPONENTI 36
IMPEGNI E STANDARD QUALITA' 37
STANDARD DI QUALITA' 37
ASPETTI RELAZIONALI 37
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 38
UMANIZZAZIONE 38
TEMPI E ACCESSIBILITA' 39
TUTELA E ASCOLTO 39
ASPETTI ALBERGHIERI E COMFORT 401

IL DIRITTO COMUNITARIO A PROTEZIONE DEI DATI DEL CITTADINO EUROPEO 41
IL POLICLINICO E LA PROTEZIONE DEI DATI DEI SUOI ASSISTITI 41
IL TITOLARE DEL DATI DEL POLICLINICO 41
I DELEGATI PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'AZIENDA POLICLINICO 41
IL PERSONALE AUTORIZZATO, INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL POLICLINICO422

L'AZIENDA: IDENTITA', MISSIONE e VALORI

ISTITUZIONE E CENNI STORICI

L'Azienda Policlinico Umberto I (di seguito PUI) è stata istituita con Decreto Legge 1 Ottobre 1999, convertito con modificazioni in Legge 2 Dicembre 1999, n. 453.
L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e si qualifica come ente strumentale della Regione ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali.
L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dal presente atto, conformemente ai principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali.
Il PUI costituisce per la Sapienza Università degli Studi di Roma (di seguito SAPIENZA) Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina. Antonella Polimeni è dal 1° dicembre 2020 rettrice della Sapienza, una delle più grandi università d'Europa, fondata nel 1303 da Papa Bonifacio VIII. Nonostante i suoi 709 anni, che la rendono una delle realtà più antiche d'Europa, viene considerata tra le più moderne, essendo da sempre orientata e proiettata verso il futuro e il progresso. Con i suoi 4000 Docenti, 4000 tra personale tecnico ed amministrativo, 11 Facoltà, 67 Dipartimenti e 30 Centri di Ricerca, la Sapienza rappresenta la più grande Università d'Europa. E' tra le università italiane meglio classificate nei ranking internazionali (Scimag Institutions Rankings), si contraddistingue per l'eccellenza scientifica in molti settori, in cui si contraddistingue: Giuridici, Politico Sociali, Economici, Scienze Naturali, Medicina e Biotecnologia Medica, Farmaceutica, Neuroscienze, Ingegneria Civile ed Architettura, Ingegneria Industriale - Aerospaziale, ICT. L'attività formativa (Corsi di Laurea, Specializzazioni, Master, Corsi di Dottorati) è rivolta ad oltre 130000 studenti. Il Protocollo di Intesa stipulato in data 10 febbraio 2016 tra Sapienza Università di Roma e Regione Lazio regola la collaborazione tra Università e Regione in ordine all'assistenza erogata dal PUI, nell'interesse della tutela della salute della collettività (Servizio Sanitario Regionale) e la funzione di didattica, formativa e di ricerca, propria dell'Università.
Nella sua attuale configurazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria - ex art. 2 comma 2, lett. a) del D.lgs 517/1999 - l'Azienda Policlinico si caratterizza come strumento per la realizzazione, in forma integrata, delle finalità inerenti la tutela della salute della collettività, obiettivo istituzionale del S.S.N, e la funzione didattico-formativa e di ricerca propria dell'Università.
L'Azienda Policlinico Umberto I è un'azienda sanitaria di livello nazionale e di alta specializzazione nonché sede di DEA di secondo livello.


Veduta storica del Policlinico

Il Policlinico dedicato al Re d'Italia Umberto I nacque per iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli, Medico e Docente Universitario della Clinica Medica di Roma. Egli promosse e sostenne l'ambizioso progetto della realizzazione di una nuova struttura ospedaliera, per una grande e moderna città di Roma, degna della capitale dello Stato unitario. L'idea dello statista fu particolarmente innovativa per quei tempi: riunire in un unico Policlinico - Ospedale d'insegnamento - le Cliniche della Facoltà di Medicina di Roma fino ad allora associate a più ospedali nel territorio della città. Il progetto del nuovo ospedale fu affidato all'Architetto Giulio Podesti che poté progettare una struttura a padiglioni collegati tra loro da tipiche gallerie a due piani allo scopo di favorire l'igiene, la lotta alle infezioni ospedaliere e la specializzazione della cura. Nei primi mesi del 1903, dopo una solenne cerimonia di inaugurazione tenutasi in Campidoglio, il Policlinico cominciò a funzionare e da subito la scelta di una costruzione "a padiglioni" permise di moltiplicare il numero dei posti letto, fino a 1.200 unità, permettendo la suddivisione dei pazienti per patologia, genere ed età. La struttura, costruita alla fine del '900, rimane anche ai nostri giorni il più grande ospedale d'Europa; occupa un'area di 300mila mq. con 54 edifici "a padiglioni" di cui 46 nel grande perimetro del quadrilatero, così chiamato perché il suo perimetro è delimitato da quattro ampie vie: viale Regina Elena, viale dell'Università, viale del Policlinico e via Lancisi.

SEDE, LOGO E SITO INTERNET

L'Azienda) ha sede legale in Roma presso il suo insediamento principale ubicato in Viale del Policlinico n. 155, CAP. 00161.

Il logo dell'Azienda è il seguente:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
REGIONE LAZIO

In tutta la documentazione aziendale, pertanto, il logo esprime sia l'appartenenza dell'Azienda al Servizio Sanitario Regionale, sia il ruolo di azienda di riferimento dell'Università per le attività assistenziali, essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina.
Il sito internet aziendale, per mezzo del quale si fornisce uno strumento informativo all'utenza e si assolvono, altresì, gli obblighi di pubblicità degli atti, provvedimenti, documenti e dati, nel rispetto delle vigenti norme in tema di trasparenza e anticorruzione, è il seguente: www.policlinicoumberto1.it

PATRIMONIO AZIENDALE

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, quali risultano dall'inventario, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri Enti Pubblici in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità.
La maggior parte degli edifici si trova all'interno delle mura perimetrali del PUI, altri edifici "fuori sede" sono quelli dislocati esternamente, anche in zone di Roma distanti dal corpus principale del PUI.
Relativamente all'edificio dell'ex presidio ospedaliero George Eastman, dopo la riacquisizione in proprietà da parte della ASL RM1, sono in corso le procedure per la definizione dei rapporti per l'uso da parte del Policlinico.
Al fine di dare attuazione alla deliberazione n. 40/2023 della Giunta della Regione Lazio, le attività assistenziali del Policlinico nell'ambito del "Progetto per il benessere e la salute della donna" sono svolte presso "Palazzo Baleani" (III Piano- Corso Vittorio Emanuele II , 244 - 00186 Roma III Piano)

MISSIONE

Il PUI, quale ente strumentale del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e in coerenza agli indirizzi programmatori della Regione Lazio, concorre a garantire l'assistenza sanitaria per il territorio regionale e garantisce l'assistenza ad alta complessità ed alto contenuto tecnologico anche in ambito sovraregionale in quanto hub e Centro di Riferimento Regionale per le funzioni determinate dalla programmazione regionale.
Il PUI, in quanto sede di riferimento per le Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina, garantisce l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell'Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione.
Il PUI organizza e gestisce le attività assistenziali e di ricerca clinica sia direttamente che attraverso il governo delle reti cliniche integrate previste dalla programmazione regionale, favorendo il trasferimento nell'attività assistenziale delle conoscenze acquisite con la ricerca clinica, la valutazione ed adozione di nuove tecnologie nonché l'implementazione di modelli gestionali innovativi.
Il PUI assicura lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nella prospettiva di:

- assicurare i livelli essenziali di assistenza secondo i principi di qualità e sicurezza delle cure e del rispetto dell'economicità nell'impiego delle risorse;
- perseguire la soddisfazione dei bisogni complessivi di salute delle persone che si rivolgono ad essa;
- creare un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale ed umano degli operatori.

Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che le aziende devono raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla programmazione sanitaria regionale e assegnati ai direttori generali all'atto del conferimento del loro incarico, armonizzando gli obiettivi di programmazione
assistenziale con quella universitaria. Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l'autonomia imprenditoriale, di cui l'atto aziendale è strumento.

VALORI

Rappresentano i principi che orientano le azioni e i comportamenti di tutti coloro che, a vario titolo, operano nel PUI e contribuiscono al compimento della sua missione. Il PUI, quale parte del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l'Università, adotta i seguenti valori di riferimento:

✓ **Centralità della Persona**

- Individuare correttamente i bisogni di salute nella loro globalità, pianificando un percorso clinico assistenziale attento alle specifiche esigenze della persona assistita;
- Realizzare una risposta assistenziale che coniughi l'elevato livello professionale e tecnico-scientifico agli aspetti organizzativi relazionali e all'umanizzazione delle cure;
- Valorizzare il ruolo degli assistiti nelle politiche di miglioramento della qualità;
- Diffondere la cultura dell'*empowerment* quale strumento per consentire di compiere, in modo libero e consapevole, le scelte e le azioni che riguardano il proprio stato di salute;
- Garantire una informazione chiara e trasparente sull'utilizzo e la valorizzazione delle risorse assegnate.

✓ **Equità**

- Rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni necessarie a consentire un accesso alle cure consapevole, corretto e tempestivo ai servizi e ai percorsi di cura offerti;
- Garantire, in base al bisogno, pari opportunità di accesso ai percorsi, ai servizi e agli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
- Ridurre la variabilità dell'assistenza allineando le competenze professionali richieste a standard organizzativi di eccellenza e monitorando l'aderenza della pratica clinica ai protocolli condivisi;
- Garantire l'accesso alle attività erogate in qualità di centro hub, sviluppando modalità organizzative capaci di rispondere alle richieste attraverso la creazione di "reti" e di percorsi aziendali;
- Contribuire al superamento di barriere ideologiche, culturali, sociali e religiose.

✓ **Qualità dell'attività assistenziale**

- Implementare percorsi clinico-assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali allo scopo di realizzare un'assistenza appropriata, evidence-based, sicura nonché ispirata al principio delle cure progressive e innovative;
- Adeguare con continuità il servizio prodotto ai bisogni della persona assistita, agli obiettivi fissati e alle priorità dell'Azienda, allo scopo di assicurare la compatibilità delle azioni e dei risultati con gli impegni assunti, tenendo in considerazione i dati di monitoraggio degli outcome e della soddisfazione degli assistiti;
- Offrire prestazioni in condizione di tutela del rischio, legato a possibili fattori ambientali, strutturali, tecnologici ed organizzativi, sia nei confronti dell'utente che dell'operatore;
- Garantire la corretta gestione della documentazione sanitaria e la trasparenza dei processi decisionali clinici, ponendo la massima attenzione al trattamento dei dati concernenti lo stato di salute della persona assistita.

✓ **Qualità dell'attività amministrativa**

- Adottare procedure amministrative volte a prevenire e ridurre i rischi dell'attività amministrativa e a garantire la massima efficienza, assicurandone l'uniformità di applicazione e l'integrazione a livello aziendale;
- Utilizzare le innovazioni tecnologiche, informatiche e gestionali come strumento per conseguire la semplificazione dell'attività amministrativa e la coerenza dei comportamenti degli uffici e dei servizi;
- Adottare i principi di legalità, trasparenza, riservatezza, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità quali prinpici guida dell'azione amministrativa.

✓ **Efficacia della didattica e formazione**

- Rappresentare sede qualificata per la formazione specifica di SAPIENZA garantendo lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi dei corsi di laurea e di specializzazione,
- attivati principalmente dalle Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina, anche integrando e valorizzando il personale del SSN in possesso dei necessari requisiti di qualificazione scientifica e professionale;
- Promuovere ed investire nel sistema di formazione continua del personale allo scopo di garantire il mantenimento, l'adeguamento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali, in sintonia con il progresso tecnico-scientifico e gestionale relativo agli ambiti specifici di ogni professionalità coinvolta nei diversi processi clinici, assistenziali e amministrativi.

✓ **Promozione della ricerca e innovazione**

- Promuovere l'attivazione di processi di avanzamento diagnostico, terapeutico e tecnologico in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini che, per complessità, gravità e rarità, necessitano di soluzioni innovative collegate allo sviluppo dell'attività di ricerca in stretta collaborazione con l'Università e con altre strutture regionali, nazionali ed internazionali;
- Promuovere l'innovazione gestionale attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi;
- Riconoscere il valore della ricerca clinica e gestionale, sia finalizzata che attivata sulla base di specifici progetti, assicurando equivalenti opportunità e modalità di partecipazione sia al personale universitario che a quello ospedaliero;
- Assicurare lo sviluppo delle attività di ricerca presso le proprie articolazioni organizzative anche attivando specifiche funzioni di promozione, coordinamento e monitoraggio;
- Valorizzare il patrimonio biomedico, conoscitivo e gestionale derivante dell'assistenza erogata a sostegno dell'attività di ricerca ed innovazione.

✓ **Eticità**

- Riconoscere la rilevanza delle problematiche di natura etica relative alla pratica clinica, alla sperimentazione e all'organizzazione, impegnandosi a tutelarne i principi nei rispettivi ambiti anche attraverso la creazione di organismi dedicati.

✓ **Trasparenza**

- Assicurare visibilità e chiarezza nei rapporti sia interni che esterni, in una logica di responsabilità dei risultati così da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- Sviluppare un sistema di comunicazione che garantisca omogeneità, coerenza, diffusione e correttezza dell'informazione, verso l'interno e verso l'esterno, assicurando massima trasparenza verso il cittadino e le forze sociali, politiche ed economiche del territorio in cui opera;

- Rendere visibile e comprensibile il processo decisionale, all'interno e all'esterno dell'Azienda, attraverso la disponibilità al confronto e la definizione di regole esplicite.

VISIONE

L'Azienda intende:

- ✓ Realizzare la piena integrazione nel SSR, concorrendo con le altre Aziende Sanitarie nonché con gli altri Soggetti Istituzionali e non, all'erogazione dell'assistenza;
- ✓ Ricoprire il ruolo istituzionale di "Azienda di riferimento regionale", declinato nell'ambito dell'alta specialità, della didattica, della ricerca e dell'innovazione gestionale e tecnologica. Ciò è garantito dal sistema integrato di competenze avanzate consentito dalla sinergia con l'Università;
- ✓ Consolidare e sviluppare il ruolo dell'Azienda come nodo della rete assistenziale e scientifica nazionale e internazionale al fine di confrontare e trasferire esperienze, nonché di rappresentare un polo di attrazione per pazienti e professionisti.

ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI, ORGANISMI E COMITATI

GLI ORGANI DELL'AZIENDA

Sono organi istituzionali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, ai sensi dell'art 3 quater del D.Lgs. 502/92 s.m.i. e dell'art 4 del D.Lgs. 517/99:

a) il Direttore Generale;
b) l'Organo di Indirizzo;
c) il Collegio Sindacale;
d) il Collegio di Direzione.

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Fabrizio d'Alba

Il Direttore Generale nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, d'intesa con il Rettore di SAPIENZA, secondo la normativa vigente, è l'organo dell'Azienda cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell'Azienda, di cui ha la responsabilità della gestione complessiva. Riveste, inoltre, la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
E' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni nelle forme della direzione strategica, dell'indirizzo, del coordinamento e del controllo, assume la responsabilità della gestione complessiva dell'Azienda, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1 quater, del d.lgs n. 502/92 e s.m.i. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale, della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Azienda nonché dell'attività assistenziale complessiva.
Esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo strategico attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, in relazione alle finalità dell'Azienda, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione aziendale.
Le funzioni attribuite al Direttore Generale si distinguono in funzioni connesse direttamente al governo complessivo dell'Azienda e funzioni di gestione e possono essere, in tutto o in parte, delegabili al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e agli altri dirigenti del PUI che in conseguenza della delega, si assumono le connesse responsabilità.
Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione ("di governo") e quelle connesse alla funzione di datore di lavoro ancorché integrata con le deleghe al personale dirigenziale per la medesima funzione, mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative del PUI, mediante adozione di atti e/o provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di budget loro assegnati.
Spettano, in particolare, al Direttore Generale:

a) Tutti i poteri di governo e gestione dell'Azienda.
b) La nomina di: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario (e loro eventuale revoca con provvedimento motivato), Collegio di Direzione, Organismo Indipendente di Valutazione, Collegi Tecnici, Collegio Sindacale, Consiglio dei Sanitari.
c) Le attività di pianificazione e controllo da attuare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale attraverso la definizione del Piano Strategico Triennale del PUI; l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Azienda; l'adozione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs.n.286 del 30.07.1999 in materia di disciplina dei controlli interni; la definizione dei criteri di valutazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; la verifica di rispondenza dei

risultati di gestione alle direttive generali impartite, con il supporto degli organismi di controllo a ciò espressamente preordinati.

d) L'adozione dell'Atto Aziendale, previa intesa con il Rettore di SAPIENZA per quanto concerne le strutture di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 517/1999 e secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del Protocollo d'Intesa (DCA 208/2016).
e) La promozione dei valori aziendali a garanzia dell'impegno dell'Azienda a perseguire le condizioni per il miglioramento continuo del servizio offerto.
f) L'adozione dei provvedimenti interni di carattere generale per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dell'Azienda.
g) La gestione della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
h) L'adozione di tutti i provvedimenti che la normativa, ivi compresi i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CC.NN.LL.), attribuisce alla competenza del Direttore Generale in quanto titolare della funzione di governo dell'Azienda, nonché tutte le competenze gestionali, non riconducibili alle competenze di governo, che, in ragione della loro specifica attinenza ai procedimenti di attuazione tecnica, organizzativa ed operativa, sono connesse e conseguenti all'esercizio delle attività di governo e comunque necessarie al funzionamento dell'Azienda per il conseguimento dei risultati programmati.

Insieme al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, costituisce la Direzione Strategica Aziendale.

L'ORGANO DI INDIRIZZO

L'Organo di Indirizzo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 517/99 e dall'art. 9 del Protocollo d'intesa (DCA 208/16) ha funzioni di garantire la coerenza e l'integrazione della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'Azienda con la programmazione didattica e ricerca scientifica dell'Università.

La composizione dell'Organo di Indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nel Protocollo d'Intesa stipulato in data 10 febbraio 2016, tra Sapienza Università di Roma e Regione Lazio e pubblicato sul BURL n.49/2016. Il Presidente è scelto all'interno del medesimo Organo ed è nominato dalla Regione d'intesa con il Rettore. I componenti dell'Organo di Indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Sono membri di diritto dell'Organo di indirizzo i Presidi delle Facoltà di Medicina. Non possono far parte dell'Organo di Indirizzo né i dipendenti dell'Azienda, né altri componenti delle Facoltà di Medicina.

Il Presidente dell'Organo di Indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell'Organo di Indirizzo senza diritto di voto.

Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono partecipare il Rettore e il Presidente della Regione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale (previsto dall'art. 3-*ter* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 517/1999) è un organo collegiale, titolare della funzione di controllo istituzionale relativa all'andamento delle attività dell'Azienda e dalla rispondenza delle attività di governo e di gestione della stessa ai principi di legalità e di economicità, con particolare riferimento agli aspetti economico-finanziari.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri nominati secondo quanto previsto dall'art. 13 del Patto per la salute 2014-2016 e dall'art.8 del vigente Protocollo d'Intesa (DCA 208/16).

Il Presidente del Collegio viene eletto dai suoi componenti all'atto della prima seduta.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta un'indennità annua lorda nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il Collegio Sindacale esercita, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge, le seguenti funzioni di vigilanza e controllo:

- verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico;
- vigila sull'osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

- fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall'Atto Aziendale;
- riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni collegialmente e, pertanto, le attività da svolgere richiedono che le relative decisioni siano prese a maggioranza assoluta. Ad ogni sindaco, individualmente, è consentito procedere ad un'attività di ispezione e controllo, ossia ad iniziative di carattere istruttorio, propedeutiche all'assunzione di decisioni che rimangono comunque sempre collegiali.

IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Collegio di Direzione, previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è l'organo tecnico collegiale con funzioni consultive che concorre al governo delle attività cliniche e che partecipa alla programmazione delle attività integrate nonché alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.
Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle Aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:

- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata;
- Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie;
- Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera**.**

In rapporto a singoli argomenti trattati, potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di Dirigenti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza.
Partecipano alle riunioni i Presidi delle Facoltà di Medicina.
Con riguardo ai criteri di funzionamento del Collegio di Direzione si fa rinvio all'articolo 4.1.3 dell'*Atto di Indirizzo per l'adozione dell'Atto di Autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Lazio* di cui alla citata DGR n. 310 / 2024.

LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla Direzione Strategica dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza per quanto attiene, rispettivamente, all'area dei servizi sanitari e all'area dei servizi amministrativi, incluse le articolazioni delle stesse dislocate nelle strutture sanitarie. Concorrono, inoltre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione aziendale.
IL DIRETTORE SANITARIO – DOTT.SSA MARIA AUGURUSA

Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., e risponde allo stesso del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnategli. Dirige i servizi sanitari dell'Azienda e svolge le funzioni assegnate dalla normativa vigente.

Oltre allo svolgimento, su delega del Direttore Generale, delle funzioni connesse direttamente allo sviluppo della *governance* clinica, il Direttore Sanitario:

- esprime parere sulle proposte di atti deliberativi del Direttore Generale ai fini organizzativi e igienico-sanitari, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore Generale;

- dirige tutti i servizi sanitari dell'Azienda ai fini organizzativi e igienico - sanitari, nelle forme della programmazione, della direttiva, dell'indirizzo, del coordinamento e del controllo proprie della funzione di governo;
- è titolare della responsabilità sanitaria dell'Azienda sul piano igienico-organizzativo e, in tale veste, si avvale della collaborazione dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata, per quanto concerne gli adempimenti inerenti alle strutture operative, nel rispetto delle loro attività istituzionali;
- coordina le iniziative e gli strumenti predisposti dalla Direzione Generale con il coinvolgimento del Collegio di Direzione per la realizzazione degli obiettivi del governo clinico;
- coordina le iniziative e gli strumenti predisposti dalla Direzione Generale con il coinvolgimento del Collegio di Direzione, nel più ampio quadro delle finalità proprie del sistema di sicurezza adottato
- dall'Azienda per conseguire l'obiettivo di circoscrivere il rischio clinico e le sue implicazioni, nell'interesse dei pazienti, degli operatori e dell'Azienda stessa;

GLI ORGANISMI, I COMITATI, LE COMMISSIONI

IL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal Direttore Sanitario e costituito con provvedimento del Direttore Generale. Esso fornisce pareri obbligatori non vincolanti al Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti nonché per le attività di assistenza sanitaria.
Il Consiglio dei sanitari formula, inoltre, proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi e svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
La composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinate da un apposito regolamento, adottato dal Direttore Generale in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i e dall'art. 8.1 dell'*Atto di Indirizzo per l'adozione dell'Atto di Autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Lazio* di cui alla citata DGR n. 310/2024.
Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata, in proporzione, la rappresentanza universitaria del personale dirigente sanitario con funzioni apicali, del personale dirigente sanitario non apicale e del personale tecnico laureato.

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è istituito ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 150/2009 così come recepito con Legge della Regione Lazio n. 1/2011.
Detto Organismo supporta la Direzione Strategica nella predisposizione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicativi in materia, monitorando il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, nonchè verificando l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013.

IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è l'organismo che autorizza qualsiasi ricerca sull'uomo relativa a specifici interventi diagnostici e terapeutici, previa valutazione globale dei progetti sul piano etico, medico-scientifico, statistico e metodologico.
A seguito della "*Riorganizzazione dei Comitati Etici Territoriali (CET) operanti nella Regione Lazio ai sensi del Dlg.s 3/2018" di cui* alla determinazione regionale G01659 del 10.2.2023, il Policlinico Umberto I afferisce alla competenza territoriale del Comitato Etico *Lazio Area 1,* con sede e Segreteria Tecnico Scientifica presso lo stesso Policlinico Umberto I e comprendente, altresì, le seguenti strutture sanitarie e relativi territori:

- AOU Policlinico Umberto I;

- AOU Sant'Andrea;
- ASL Latina;
- ASL Rieti;
- ASL RM 1;
- AO San Giovanni Addolorata.

L'articolo 12, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 158 del 2012, prevede che *"la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati".*
La segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale *Lazio Area 1* è posta all'interno della UOSD

IL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)

Il PUI istituisce il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CC-ICA) quale strumento efficace per garantire la sicurezza del paziente durante la sua permanenza in ospedale attraverso un approccio gestionale e di controllo del rischio infettivo riferito in modo globale a pazienti, operatori sanitari e visitatori, e diffuso a tutti i livelli del processo assistenziale.
Il CC-ICA è un organismo aziendale multidisciplinare con funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e di coordinamento delle attività finalizzate alla riduzione dell'incidenza delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) in tutti gli ambiti aziendali, anche mediante valutazione del quadro epidemiologico delle ICA stesse e dei fattori di rischio ad esse correlati.
Rappresenta una delle dimensioni di governo clinico e assicura la corretta gestione delle infezioni correlate all'assistenza in un'ottica di miglioramento della qualità e della sicurezza nella struttura sanitaria.
È un organismo collegiale con funzioni di programmazione, indirizzo e verifica delle seguenti attività:

- Elabora, monitora ed implementa un programma aziendale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate ai processi assistenziali;
- Predispone il piano annuale delle attività nel rispetto di leggi e regolamenti, da validarsi a cura del Direttore Sanitario (PAICA contenuto all'interno del Piano annuale per il rischio sanitario-PARS);
- Valuta e approva le procedure e i protocolli relativi alla prevenzione delle ICA, redatti da Gruppi di Lavoro multidisciplinari, la cui responsabilità di applicazione è demandata ai Capi di Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi strategici Aziendali;
- Valida e promuove la diffusione, a livello aziendale, di linee guida sull'utilizzo appropriato degli antibiotici, dei presidi e dei dispositivi medici e sulle procedure di disinfezione e sterilizzazione;
- Valida e promuove la diffusione, a livello aziendale, di protocolli assistenziali mirati alla riduzione del rischio infettivo/biologico per i pazienti;
- Formula proposte sui piani di aggiornamento e formazione del personale nell'ambito di azioni prioritarie.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Sanitario. La composizione del Comitato è interdipartimentale e ha lo scopo di garantire la convergenza di professionalità e competenze di carattere scientifico, assistenziale e gestionale diverse, coinvolgendo le seguenti figure: infettivologo, farmacista, microbiologo, risk manager, referente area medica, referente area chirurgica, referente area dell'emergenza, nominati dal rispettivo Direttore DAI e dal Direttore del Dipartimento delle Professioni sanitarie.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un apposito regolamento adottato dal Direttore Generale.

IL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)

Il *Comitato Valutazione Sinistri* è un collegio consultivo multidisciplinare ristretto, in *staff* alla Direzione Generale, il cui compito è anzitutto quello di presiedere la funzione di governo del rischio assicurativo e di valutazione dei sinistri per danno alla persona per responsabilità medico – sanitaria.
Il CVS persegue le proprie finalità istituzionali attraverso le seguenti attività:

- raccoglie e verifica di tutte le informazioni indispensabili;
- valuta i sinistri allo scopo di individuarne il nesso causale con gli eventi che li hanno prodotti;
- individua una possibile strategia condivisa di gestione del sinistro, valutandone l'impatto economico;
- valuta le tipologie ed entità degli eventuali danni arrecati a terzi con il coinvolgimento delle varie professionalità aziendali necessarie per un'analisi dei sinistri anche in un'ottica preventiva finalizzata a scongiurare che si ripetano;
- decide in merito alla possibilità di partecipare ad eventuali richieste di mediazione avanzate nei confronti dell'Azienda, nonché in merito all'opportunità di promuovere a nome dell'Azienda procedure di mediazione, come previsto dalla vigente normativa;
- formula il proprio giudizio in ordine alla definizione del sinistro, che comunica alla Direzione Generale, attraverso la trasmissione del verbale relativo alle riunioni intervenute;
- definisce le riserve tecniche al fine di quantificare in maniera adeguata il "fondo riserve sinistri" e il "fondo rischi", contribuendo, altresì, all'aggiornamento periodico di entrambi i fondi.

La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento Aziendale redatto sulla base delle Linee guida della Regione Lazio di cui alla Determinazione 23 novembre 2023, n. G15665 avente ad oggetto il "*Documento di indirizzo sulla gestione dei sinistri da responsabilità medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)".*

Sono componenti del CVS:

- Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e/o Legale che gestisce il contenzioso aziendale;
- Medico Legale aziendale;
- Risk Manager;
- Esperto nella gestione liquidativa, cui spetta la quantificazione economica delle possibili voci di danno, la valutazione delle proposte liquidative della Compagnia assicuratrice, ove presente, e il supporto tecnico nella definizione e nell'aggiornamento periodico del fondo riserva sinistri e del fondo rischi (*loss adjuster*);
- Avvocato esperto in materia di sinistri RCT iscritto all'Albo;
- Un Dirigente Medico in rappresentanza della Direzione Sanitaria

IL COMITATO BUON USO DEL SANGUE (COBUS)

Il *Comitato aziendale per il Buon uso del Sangue* (COBUS) ha il compito di:

- predisporre e aggiornare linee guida interventi di sensibilizzazione per l'utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
- predisporre e attuare protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile, con particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati (*Patient Blood Management*);
- definire sistemi di valutazione del consumo di sangue nelle singole Unità operative al fine di promuovere la corretta indicazione alla terapia trasfusionale, secondo il principio del corretto rapporto rischio/beneficio;
- promuovere l'adozione di programmi attuativi di terapia alternativa all'uso del sangue omologo (quali l'auto-trasfusione con pre-deposito nei casi previsti, l'emodiluizione normovolemica, il recupero peri-operatorio, secondo evidenze sciEntifiche);
- consolidare il reporting degli eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di migliorare la sicurezza del paziente;
- contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati.

I referenti istituzionali del Comitato sono Il Direttore Sanitario e il Direttore del *Servizio Immunotrasfusionale*

del PUI.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un apposito regolamento adottato dal Direttore Generale.

IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONEDEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

Il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG) sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il *Comitato Pari Opportunità e il Comitato sul fenomeno del mobbing*, dei quali assume tutte le competenze previste dalla legge.
Il CUG espleta le proprie funzioni nei confronti di tutto il personale dell'Azienda ed è un organismo paritetico in quanto costituito da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti aziendali, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Presidente è designato dal Direttore Generale. Il Comitato, è dotato di un proprio regolamento e svolge la propria attività nell'interesse dell'Azienda.
Il CUG è un importante strumento per attuare politiche e azioni positive in tema di diritti delle persone, prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, molestia e violenza, al fine di sostenere i processi di *empowerment* del personale, per una migliore qualità della vita, contribuendo alla crescita della cultura del rispetto, delle pari opportunità e a migliorare il rapporto vita privata-lavoro. Le aree di competenza del Comitato, in cui svolge un ruolo propositivo, sono:

- il benessere organizzativo e individuale, anche in termini di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
- la parità di genere e pari opportunità,
- la conciliazione vita privata/lavoro,
- contrasto a ogni forma di discriminazione, violenza, mobbing,
- iniziative formative e di aggiornamento sulle materie di competenza.

Le aree di competenza del Comitato, in cui svolge un ruolo consultivo, sono:

- progetti di riorganizzazione aziendale
- piani di formazione del personale
- flessibilità e lavoro agile
- criteri di valutazione del personale
- CCNL integrativa sulle materie di competenza.

Il Comitato svolge un ruolo di verifica sugli esiti delle azioni positive in materia di pari opportunità, promozione del benessere organizzativo, prevenzione del disagio lavorativo, contrasto al *mobbing* e ad ogni forma di violenza o discriminazione.
Il CUG concorre alla definizione ed alla promozione dei piani formativi e informativi di concerto con tutte le Strutture interessate condividendone dati e iniziative volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute dei dipendenti, al fine di:

- sviluppare una cultura organizzativa basata sulla gestione positiva dei conflitti e sulla valorizzazione delle differenze e delle specificità individuali, migliorando i rapporti di lavoro anche tramite comportamenti ispirati al rispetto, alla collaborazione, alla prevenzione di situazioni conflittuali e alla condivisione, finalizzati ad accrescere la motivazione al lavoro e il benessere organizzativo e individuale e, con essi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- promuovere un uso consapevole del linguaggio, non discriminatorio e rispettoso delle differenze;
- diffondere una cultura dell'inclusione, del contrasto alle discriminazioni e del rispetto delle diversità presenti nel contesto organizzativo, ispirata a principi di equità, pari opportunità, mutua collaborazione e correttezza;
- sviluppare senso di responsabilità e sensibilità per prevenire e contrastare fenomeni di violenza e molestie;

- sviluppare strumenti di work-life balance e indagini di clima, facilitando l'inserimento di personale con disabilità, anche acquisita successivamente o per lunghe assenze dal servizio;
- promuovere l'ascolto organizzato interno;
- sostenere e diffondere un corretto e sano stile di vita, in un Policlinico ecosostenibile.

Il Comitato partecipa al network "*Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia*" moltiplicatore delle potenzialità di ciascun Comitato, con l'obiettivo di facilitare la progettazione di azioni comuni e la realizzazione di uno scambio virtuoso di idee, competenze e buone prassi.

IL COMITATO PER L'OSPEDALE SENZA DOLORE

Il PUI considera il trattamento del dolore un intervento di primaria importanza.
Il Comitato Ospedale Senza Dolore, in linea con quanto stabilito dalle linee guida ministeriali inerenti al progetto "Ospedale senza dolore" e dalla legislazione ospedaliera regionale del Lazio, svolge i seguenti compiti: la rilevazione corretta e costante del sintomo dolore con scale validate e di semplice applicazione e comprensione; trattamenti pronti e corretti in base a protocolli elaborati sulla base delle evidenze; il monitoraggio dell'uso dei farmaci analgesici; il potenziamento dei servizi di terapia del dolore; la formazione del personale.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un apposito regolamento adottato dal Direttore Generale.

LA COMMISSIONE PER IL PRONTUARIO TERAPEUTICO (CPTO)

Gli atti di indirizzo strategico regionale e i Programmi Operativi a salvaguardia degli obiettivi di rientro dai disavanzi sanitari hanno previsto interventi e azioni di razionalizzazione della spesa farmaceutica tra cui rivestono particolare importanza l'attuazione di percorsi terapeutici per categorie di farmaci alto spendenti, la revisione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero e la razionalizzazione dell'uso del farmaco in ospedale.
Il PUI istituisce la *Commissione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero* (CPTO), presieduta dal Direttore Sanitario, preposta alla stesura e all'adozione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO), al relativo aggiornamento nonché ad assicurarne la corretta applicazione secondo la regolamentazione e le procedure stabilite a livello regionale e locale.

Inoltre, alla Commissione compete:

- effettuare il monitoraggio dei consumi dei medicinali per categoria terapeutica, principio attivo e area clinica o reparto e, sulla base dei consumi rilevati, predisporre specifici protocolli di impiego diffondendoli ai medici/reparti interessati;
- analizzare gli usi off-label diffusi e sistematici in ambito aziendale;
- raccogliere informazioni ed effettuare analisi sull'utilizzo di farmaci specifici non in PTO;
- produrre rapporti periodici sulla propria attività svolta;
- proporre l'inserimento di nuovi medicinali in PTO.

Il Direttore della Farmacia è componente obbligatorio della Commissione che è supportata, per tutte le attività istruttorie, da una segreteria tecnica composta da Farmacisti. Per la trattazione di specifici argomenti, la CPTO può avvalersi di esperti individuati dalla stessa, senza maggiori oneri per il bilancio dell'Azienda.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato da un apposito regolamento adottato dal Direttore Generale

IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei garanti è istituito in applicazione dell'articolo 15, comma 4, lett. i) del vigente Protocollo d'Intesa Regione Lazio / Università Sapienza - che ha demandato all'Atto Aziendale l'individuazione, tra l'altro, della procedura di nomina, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore generale, dei garanti per i procedimenti di sospensione, di cui all'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 517/1999.

Il Comitato dei garanti ha funzione consultiva del Direttore generale ("previo parere conforme") nel quadro del procedimento attivato dallo stesso Direttore generale, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio da parte del personale docente e ricercatore strutturato presso il Policlinico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 14, del D. Lgs. n. 517/1999.

Il Comitato dei garanti del Policlinico, che resta in carica per n. 3 anni, è costituito da n.3 componenti, di cui uno nominato dal Rettore, uno dal Direttore Generale e il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra Direttore Generale e Rettore.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'Atto Aziendale è stato elaborato considerando la natura giuridica del Policlinico Umberto I di Roma quale Azienda Ospedaliero-Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 517/1999, nella quale trovano necessaria ed ineludibile compenetrazione le attività di didattica e di ricerca e le attività assistenziali.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 7 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell'art. 17 bis del d.lgs. 502/92, la struttura organizzativa dell'Azienda si fonda sull'Organizzazione Dipartimentale - che si concretizza attraverso l'istituzione di Dipartimenti ad Attività Integrata che garantiscono i collegamenti tra assistenza, didattica e ricerca - e sulle Aree di Governo aziendale che comprendono un Dipartimento assistenziale.

La nuova Organizzazione Dipartimentale delineata nell'Atto Aziendale, realizzata in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi, nonché di ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e in base a criteri di natura economico-finanziaria, clinica ed epidemiologica, è adottata nel rispetto della *"Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015"* di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 7.12.2023.

L'assetto organizzativo del PUI si articola in **n. 9 Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI),** ai quali fanno riferimento, allo stato, n. 64 Unità Operative Complesse (UOC) e n. 103 Unità Operative Semplici anche a valenza dipartimentale (n. 36 UOSD e n. 67 UOS).

Per quanto riguarda l'organizzazione delle **Aree di Governo Aziendale**, l'assetto organizzativo del PUI si articola in:

- Funzioni di staff alla Direzione generale;
- Area Tecnico - Sanitaria;
- Area Tecnico - Amministrativa;
- Dipartimento delle Professioni Sanitarie.

In considerazione dell'entità delle risorse gestite e del grado di complessità delle funzioni e dei processi, le funzioni amministrative e tecniche e quelle di *staff* alla Direzione Aziendale, nonché le funzioni riconducibili al Dipartimento delle Professioni Sanitarie, sono anch'esse articolate in strutture operative (complesse e semplici, anche dipartimentali) da ricomprendere nelle citate Aree di Governo aziendale.

L'**Organigramma** dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I è consultabile al seguente link https://www.policlinicoumberto1.it/categoria_amm_trasp/atti-amministrativi-generali/

I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

Il DAI è costituito come centro di responsabilità e di costo e, in coerenza con le previsioni del vigente Protocollo d'Intesa, è l'articolazione organizzativa fondamentale dell'Azienda e costituisce l'elemento di riferimento per l'attribuzione delle responsabilità e per l'allocazione, la gestione e l'utilizzazione delle risorse destinate alla realizzazione delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, al fine del conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Università e del SSR.
Il DAI garantisce un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più elevato possibile di appropriatezza delle cure, mediante l'integrazione con i processi di didattica e di ricerca, nonché la tempestività e coerenza nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche.

Il PUI, nel disciplinare la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei DAI, persegue la finalità di:

- prevedere una composizione dei Dipartimenti che favorisca lo sviluppo dell'innovazione assistenziale, la continuità assistenziale, lo sviluppo professionale e la coerenza tra le attività assistenziali, didattica e di ricerca;

- assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- prevedere e favorire lo sviluppo tecnologico.

D.A.I. Chirurgico
D.A.I. Emergenza- Accettazione, Anestesia e Aree Critiche
D.A.I. Medicina Interna e Specialità mediche
D.A.I. Medicina Interna, Scienze endocrino-metaboliche e Malattie Infettive
D.A.I. Materno Infantile e Scienze Uro Ginecologiche
D.A.I. Medicina Diagnostica e Area Radiologica
D.A.I. Testa Collo
D.A.I. Attività Onco-Ematologiche, Dermatologiche e della Diagnostica Anatomo-Patologica
D.A.I. Neuroscienze e Salute Mentale

Home Page - Policlinico Umberto I

L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)

L'attività libero-professionale intramuraria si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai Dirigenti Medici e Sanitari dell'Azienda, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'Azienda stessa a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I attua l'istituto dell'attività libero professionale intramoenia secondo le indicazioni dettate dalla normativa.
La gestione dell'ALPI coinvolge aspetti di natura sanitaria e amministrativa che risultano trasversali a diverse unità operative.
Le funzioni di programmazione e di controllo afferiscono alla Direzione Sanitaria Aziendale, mentre le funzioni amministrative sono assicurate dalla UOSD ALPI e dalla UOC Risorse economiche e Finanziarie

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il *risk management* introduce un'ottica preventiva di misura e governo dei rischi finalizzata a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi avversi per l'organizzazione e introducendo dinamiche positive dirette a migliorare la gestione.
Per sistema di controllo interno si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, volte a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi per una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
Il risk management viene declinato in vari ambiti quali, principalmente:

- ✓ **rischio sanitario** correlato alla sicurezza del paziente quale insieme di attività volte a identificare, valutare ed eliminare i rischi attuali e potenziali all'interno delle strutture sanitarie al fine di assicurare qualità e sicurezza alle prestazioni assistenziali;
- ✓ **rischio amministrativo-contabile** (art. 97 Costituzione Italiana) correlato alla salvaguardia del patrimonio aziendale, all'integrità e affidabilità delle informazioni economico-finanziarie, al rispetto di leggi, regolamenti e contratti, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa;
- ✓ **rischio di corruzione** (L. 190/2012) inteso come comportamento che si discosta dai doveri del pubblico dipendente in virtù di interessi privati che comportano profitti monetari o di status;
- ✓ **rischio lavorativo** (D.Lgs 81/2008): garantire che il lavoratore sia posto nella condizione di lavorare senza esporsi al rischio di incidenti e dotare il luogo di lavoro degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti;

- ✓ **rischio ambientale** correlato alle attività che possono avere un impatto ambientale diretto o indiretto basato non solo sulla prevenzione di eventuali inconvenienti, ma anche su un programma di miglioramento continuo del comportamento aziendale nei confronti dell'ambiente.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Le Aziende Sanitarie, in base al vigente quadro normativo, sono sottoposte ad un sistema di controlli esterni e di controlli interni:

- controlli esterni sono posti in essere dallo Stato (attraverso i competenti Ministeri), dalla Regione e dalla Corte dei Conti.
- Controlli interni da:
  - ✓ **Collegio Sindacale,** preposto alla funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile,
  - ✓ **Funzione di Controllo di Gestione,** preposta alla verifica dell'efficienza, della efficacia e dell'economicità della gestione ai fini dell'ottimizzazione dei risultati attesi, tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
  - ✓ **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, valida la Relazione sulla performance ed è preposto a sovrintendere monitorare il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati
  - ✓ **Collegi Tecnici**: organismi che, nell'ambito del processo di valutazione del personale dirigente dell'area medica e dell'area tecnica professionale, sanitaria ed amministrativa, sono preposti alle verifiche riguardanti le attività professionali svolte e i risultati conseguiti, rispetto ai risultati attesi.
  - ✓ **Servizio Ispettivo,** previsto dall'art. 1, c. 62, della Legge n. 662 del 23.12.1996 e s.m.i per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 56 a 65 dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

STRUMENTI DI TUTELA DEI CITTADINI

PRINCIPI GENERALI

Il PUI, nel perseguire il suo impegno ad assicurare il più elevato livello di risposta alla domanda di salute quale stato di completa integrità fisica, psichica e sociale, organizza le proprie risorse in modo da garantire percorsi clinico-assistenziali pertinenti e tempestivi a tutti i cittadini in condizioni di parità e nel rispetto dei principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta e di partecipazione.
Il PUI riconosce la centralità della persona nell'erogazione e nell'accesso alle prestazioni sanitarie, nonché nel perseguimento della continuità assistenziale.

Riconosce la funzione delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro, impegnate nella tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto per l'esercizio delle proprie competenze.

Sono individuati quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati:

- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Il processo di Audit Civico;
- la Carta dei Servizi;
- Associazioni di tutela e Tribunale del Malato.

L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) previsto e normato dall'art. 12 D. Lgs. n. 29/1993, dal DPCM 11 ottobre 1994 nonché dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 assicura la comunicazione con gli utenti, sviluppando l'informazione sulle prestazioni sanitarie e le relative modalità di accesso.
In particolare l'URP acquisisce le osservazioni e i reclami presentati dai cittadini e provvede a curarne la gestione. Raccoglie, classifica e archivia le segnalazioni e gli esposti in un apposito archivio e predispone, con cadenza annuale, una relazione alla Direzione Aziendale sulle segnalazioni e sui reclami pervenuti e sull'esito degli stessi. Detta relazione è accompagnata da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, relazionali e di accesso alle prestazioni, per il superamento dei fattori di criticità emersi.

L'URP cura i rapporti con le Associazioni di volontariato e le Associazioni di tutela dei cittadini e trasmette periodicamente alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di partecipazione e di soddisfazione.

L'Azienda garantisce che l'URP, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento, si avvalga di personale opportunamente formato e dotato delle caratteristiche di cui al d.p.r. n. 422/2011 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione*".

Sono attività proprie dell'URP ai sensi della L. 7 giugno 2000 n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*":

- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'Azienda;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- garantire la reciproca informazione tra l'URP e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché tra gli URP delle varie amministrazioni.

IL PROCESSO DI AUDIT CIVICO

L'Audit Civico rappresenta uno degli strumenti più importanti per la partecipazione dei cittadini alle politiche

sanitarie aziendali. Consiste in una operazione di analisi critica e sistematica dell'azione dell'Azienda, effettuata in collaborazione con associazioni di tutela dei cittadini e finalizzata a:

a) rappresentare il punto di vista del cittadino e assicurarne la partecipazione;
b) rendere trasparente e verificabile l'azione dell'Azienda.

L'analisi delle azioni svolte dall'Azienda, utilizzando indicatori definiti e attraverso una attività di progettazione fra referenti civici e referenti aziendali, favorisce una accurata raccolta di dati e definisce con precisione la situazione aziendale. Consente una costante attività di monitoraggio di eventuali criticità individuate, favorendo le implementazioni di azioni correttive e/o migliorative e la promozione di progetti orientati al miglioramento della qualità ponendo al centro le esigenze e i bisogni del cittadino.

LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi rappresenta il patto tra l'Azienda e il cittadino e riassume gli impegni cui il PUI si obbliga nei confronti dell'utente.

La Carta dei Servizi è un documento per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi e alle prestazioni della struttura e per fornire uno strumento informativo semplice e di facile consultazione, periodicamente aggiornato ed integrato.

La Carta dei Servizi in formato cartaceo rappresenta sinteticamente la struttura dell'Azienda, i servizi disponibili e le modalità di accesso (ubicazione, orari di apertura, dove reperire modulistica ecc.) e viene aggiornata successivamente all'adozione dell'Atto Aziendale.

La Carta dei Servizi in formato multimediale è rappresentata dal sito web istituzionale dell'Azienda, dove quotidianamente vengono aggiornate ed implementate tutte le informazioni di interesse per l'utenza circa i servizi, le attività, le strutture e l'organizzazione aziendale.

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi:

- imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all'accesso ai servizi;
- piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
- definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell'Azienda rispetto alla promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità stessa;
- individuazione di specifiche strutture preposte alla tutela dei diritti dei cittadini;
- ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o tramite le Associazioni che li rappresentano attraverso modalità e strumenti di partecipazione e coinvolgimento.

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI PAZIENTI

L'Azienda favorisce in tutti i processi decisionali e operativi le azioni atte a sviluppare adeguati livelli di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini, nonché modalità atte a consentire l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni non aventi fini di lucro (Tavolo Misto Permanente). L'AOU Policlinico Umberto I promuove la collaborazione con associazioni di tutela dell'utente, anche stipulando con esse convenzioni e protocolli d'intesa volti a definire modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì l'eventuale concessione in uso dei locali, le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.

STRUMENTI DI GOVERNO CLINICO

Per governo clinico si intende l'insieme degli strumenti gestionali organizzativi attraverso i quali l'Azienda ed i Professionisti assumono una responsabilità diretta relativamente al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza finalizzato al perseguimento di elevati livelli dei servizi sanitari.

Tali strumenti sono rappresentati dalla definizione di precise linee di responsabilità, individuali e collettive,

dalla trasparenza e condivisione dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma comparativa, dai programmi di miglioramento della qualità, dall'audit clinico e dalla valutazione della performance clinica, dalla pratica clinica basata sulle prove di efficacia, dai percorsi clinico - assistenziali, dalla pratica della gestione e della comunicazione del rischio e dallo sviluppo delle attività di accreditamento professionale.

Il PUI sviluppa inoltre la capacità di produrre ricerca e innovazione e gestisce l'attività come funzione istituzionale, intrinseca alla primaria funzione assistenziale, anche mediante l'istituzione della UOSD *Ricerca Clinica e Clinical Competence (URCCC),* una struttura aziendale di supporto all'organizzazione e al coordinamento di studi clinici, finalizzata a promuovere la qualità della sperimentazione clinica in accordo con le *Good Clinical Practice*.

LE RETI INTERAZIENDALI

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I si inserisce in un modello regionale di assistenza sanitaria sempre più orientato all'integrazione interaziendale, organizzato secondo il sistema hub e spoke.
La rete in sanità rappresenta un approccio integrato e collaborativo che mira a migliorare la qualità, l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sanitari attraverso la cooperazione tra diverse entità del settore.
Nella realtà del PUI, le principali reti attivate sono:

Area Emergenza

- Rete Trauma Maggiore: Coordinazione delle cure per i traumi maggiori, migliorando la risposta tempestiva e la gestione dei pazienti traumatizzati;
- Scompenso Cardiaco: Gestione integrata dei pazienti con scompenso cardiaco acuto e cronico;
- Sepsi e Shock Settico: Protocollo per la rapida identificazione e trattamento della sepsi e dello shock settico;
- Ictus: Coordinazione delle cure per pazienti colpiti da ictus per ottimizzare i tempi di intervento e migliorare i risultati;
- Frattura del Collo del Femore: Gestione specifica per le fratture del collo del femore, con focus sulla riduzione dei tempi di intervento e miglioramento del recupero;

Area Cronicità e Malattie Rare

- Fibromialgia: Rete di assistenza per la gestione della fibromialgia, garantendo supporto multidisciplinare e continuità delle cure;
- Fibrosi Cistica: Coordinamento delle cure per i pazienti affetti da fibrosi cistica, migliorando l'accesso ai trattamenti e la qualità della vita

Area Trapianti d'Organo

- Trapianti di Fegato: Organizzazione e gestione del processo di trapianto di fegato, ottimizzando i tempi di attesa e migliorando i risultati clinici;
- Trapianti di Polmone: Rete per la gestione dei trapianti di polmone, garantendo un follow-up adeguato e supporto post-trapianto;
- Trapianti di Rene: Coordinazione delle attività relative ai trapianti di rene, migliorando la compatibilità e riducendo le complicanze

Rete Oncologica

- Breast Unit: Struttura specializzata nella diagnosi e trattamento del cancro al seno, con un approccio multidisciplinare e personalizzato;

- Ca Prostata: Gestione integrata per il trattamento del cancro alla prostata, migliorando l'accesso a diagnosi precoci e terapie avanzate;
- Ca Polmone: Rete per la gestione del cancro al polmone, con focus su diagnosi tempestive e trattamenti innovativi;
- Ca Colon Retto: Coordinazione delle cure per il cancro del colon retto, migliorando la prevenzione, diagnosi e trattamento

Queste reti sono progettate per garantire un'assistenza sanitaria di alta qualità, promuovendo la collaborazione tra diverse entità del settore sanitario e migliorando l'efficienza e l'accessibilità delle cure.

È stato realizzato il Punto Oncologico di Accesso e di Continuità di Cura (PACO) in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione regionale n. G01829/2023 del 13.02.2023 "Linee di indirizzo organizzative per la Rete oncologica regionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 59/CRS del 17 aprile 2019", finalizzato all'orientamento e all'accesso alle cure del paziente con patologia oncologica, dal sospetto diagnostico iniziale e per tutte le diverse fasi della malattia.

I PERCORSI CLINICI, I PDTA E LE *UNIT*

PERCORSI CLINICI

In linea con gli atti regionali di programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 e utilizzando come leva strategica i risultati PREVALE e le attività di audit interno, il PUI che ha già intrapreso percorsi di integrazione multiprofessionale e multidisciplinare con lo sviluppo di PDTA e l'attivazione di Unit per patologia, persegue gli obiettivi di integrazione, finalizzati alla presa in carico e alla continuità delle cure fra i vari livelli assistenziali, anche attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi clinici (percorso chirurgico, percorso nascita, percorso oncologico, percorsi in emergenza, etc).
I percorsi clinici principali oggetto di analisi e sviluppo di programmi di miglioramento aziendale sono:

a. Percorsi in emergenza

A tal fine il PUI ha attivato e contestualizzato la *CO centrale Operativa - Team Operativo Ospedaliero* (TOH) per la gestione di tutti i flussi di ricovero da pronto soccorso ed elettivi e per la gestione di tutti i trasferimenti intra-aziendali, nonché per l'interfaccia con le strutture di ricovero di post-acuzie e con i setting assistenziali territoriali, come da direttiva di Regione Lazio. Nell'ambito della TOH operano i seguenti uffici: il servizio dei Facilitatori dei ricoveri, il Servizio Sociale Aziendale e l'Unità Valutativa Multidimensionale.
In questo ambito si inseriscono percorsi dedicati tempo-dipendenti, con programmi di riorganizzazione ed implementazione delle reti ictus, cardiologica e trauma.

b. Percorsi chirurgici

Per quanto riguarda la chirurgia programmata, il PUI ha definito le linee di indirizzo per il percorso del paziente chirurgico per setting assistenziale e complessità di cura nel Piano strategico aziendale per l'attività chirurgica (PSAAC) che prevede un programma di azioni di miglioramento in corso di attuazione.
Le modalità operative per la gestione di linee di attività specifiche e critiche sono disciplinate con appositi regolamenti

c. Percorsi oncologici

In riferimento all'ambito oncologico, è stato formalizzato il servizio PACO e il Piano Oncologico Aziendale con riferimento anche ai diversi percorsi definiti per patologia.

Il Punto Oncologico di Accesso e di Continuità di Cura (PACO) è stato realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione regionale n. G01829/2023 del 13.02.2023 "Linee di indirizzo organizzative per la Rete oncologica regionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 59/CRS del 17 aprile 2019" ed è finalizzato all'orientamento e all'accesso alle cure del paziente con patologia oncologica, dal sospetto diagnostico iniziale e in tutte le diverse fasi della malattia.

Numerosi percorsi per patologia sono sviluppati come PDTA e la discussione dei casi condivisa con modalità

integrate nelle Unit.

Ulteriori percorsi clinici:

- Percorso nascita: la valutazione dell'appropriatezza al parto cesareo è tra le principali attività con la quale il Comitato percorso nascita promuove e sviluppa il piano di miglioramento;
- Percorso Rosa per la presa in carico delle persone e dei minori vittime di violenza;
- Percorsi di Genere presso il polo ambulatoriale di Palazzo Baleani;
- Percorso Special needs in odontoiatria pediatrica;
- Percorsi per pazienti con patologie rare

La Unit rappresenta il modello organizzativo che esprime la presa in carico mediante la definizione di un PDTA, dove la gestione del percorso della paziente è affidato ad un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale di operatori sanitari dedicati.
Fra le altre è istituita la *Cancer Neck Head Unit* (Unità di Chirurgia Oncologica del Distretto Testa Collo) che confluirà nel PDTA dei tumori del distretto del testa collo in corso di elaborazione.
Il funzionamento delle Unit è disciplinato da apposito regolamento.
I PDTA attivati all'interno del PUI, che rispondono alle caratteristiche su descritte sono i seguenti:

- Per l'area trapianti:

PDTA Trapianto di Fegato, PDTA Trapianto di rene, PDTA Trapianti di Polmone;

- Per l'area oncologia:

PDTA CA Mammella, PDTA CA Prostata, PDTA CA Polmone, PDTA CA Colon Retto;

- Per l'area cronicità- malattie rare:

PDTA Fibromialgia, PDTA Fibrosi Cistica;

- Per l'area emergenza:

PTDA Ictus; PDTA Frattura del collo del femore, PDTA Gestione della sepsi e dello shock settico, PDTA gestione del politrauma, PDTA Diverticolite Acuta non complicata;

Nell'ambito della programmazione integrata, aderendo alle indicazioni regionali, è stato adottato il Panflu - Piano strategico aziendale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale con l'obiettivo principale di rafforzare la preparedness nella risposta a una futura pandemia attraverso la pianificazione delle azioni e l'identificazione delle strategie necessarie a minimizzare i rischi legati alla diffusione e alla circolazione di patogeni emergenti.

Il Centro facilita e supporta l'integrazione dei percorsi terapeutici, e in generale assistenziali, fra Ospedale e Territorio, riconsiderando, se necessario, le indicazioni fornite in dimissione ospedaliera o da visite specialistiche, prendendo in carico le segnalazioni dei Medici di Medicina Generale in merito alla continuità delle terapie tra Ospedale e Territorio a seguito della dimissione dei propri assistiti.

Inoltre il Centro, attraverso la Farmacia ospedaliera, effettua il monitoraggio della corretta erogazione del primo ciclo terapeutico alla dimissione così che si realizzi la continuità terapeutica nell'immediato post-ricovero.

L'UNITA' DI DEGENZA A GESTIONE INFERMIERISTICA (UDI)

Il PUI ha attivato una Unità di degenza a gestione infermieristica (UDI), un modulo di ricovero di 12 posti letto tecnici funzionali a media-bassa intensità assistenziale gestito da personale infermieristico, con l'obiettivo della presa in carico del paziente che, superata la fase acuta della malattia, necessita di assistenza infermieristica ad alta intensità.
La UDI contribisce alla promozione dell'appropriatezza assistenziale ed organizzativa oltre che all'aumento del turn over dei posti letto (prevalentemente di area medica), garantendo un adeguato percorso di uscita a pazienti "fragili", dimissibili, ma senza una condizione socio-economica protetta.

Nella UDI sono accolti ed assistiti pazienti provenienti da tutte le unità operative ospedaliere che continuano ad essere seguiti da punto vista clinico dal medico dell'Unità Operativa di provenienza e che sono gestiti sotto il profilo assistenziale dal personale infermieristico, con l'obiettivo di facilitarne la dimissione attraverso uno specifico percorso di continuità assistenziale.

Si tratta, nella fattispecie di pazienti:

- affetti da patologie cronico-degenerative, che possono essere dimessi dal reparto per acuti, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica e di assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore;
- dimissibili ma per i quali è necessario organizzare un adeguato percorso di uscita dall'ospedale per: a) rientrare al proprio domicilio in assistenza domiciliare; b) essere trasferiti presso altra struttura residenziale riabilitativa postacuzie.

Il funzionamento della UDI è disciplinato da apposito regolamento

UOSD RICERCA CLINICA E CLINICAL COMPETENCE (URCCC)

Il PUI ha costituito, in *staff* alla Direzione Generale, la UOSD Ricerca Clinica e *Clinical Competence* (URCCC), una struttura nella quale sono unificate le funzioni di Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico *LAZIO Area 1* e quelle di supporto alla ricerca clinica.
La UOSD è istituita con lo scopo di valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e la sostenibilità di farmaci, prodotti biologici, dispositivi, attrezzature, presidi, nuove tecnologie, procedure mediche e interventi chirurgici, supportando la Direzione Aziendale nelle decisioni strategiche atte a promuovere l'eccellenza della governance sanitaria e un sistema integrato di *Clinical Governance.*

La UOSD supporta inoltre, non solo dal punto di vista regolatorio, ma anche amministrativo, gli sperimentatori e i promotori di studi clinici, preliminarmente all'approvazione da parte del Comitato Etico Territoriale e nel corso di tutta la sperimentazione clinica.

La UOSD intrattiene i rapporti con Promotori, Organizzazioni di Ricerca a contratto (CRO), Monitor e Sperimentatori responsabili durante l'intero svolgimento del protocollo di studio.
La UOSD gestisce e cura, tra l'altro, le attività progettuali e la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR M6C2.1, conserva la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, provvede alla creazione del CUP ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR.

SERVIZI AL CITTADINO

Il Policlinico Umberto I offre ai pazienti servizi informativi e assistenziali, telematici e in loco.
Servizi - Policlinico Umberto 1

PRONTO SOCCORSO

Il Pronto Soccorso è il primo accesso per i cittadini che vivono una condizione d'emergenza
Il PUI è sede del DEA di II Livello, è dotato di cinque pronto Soccorso specialistici, più un "Percorso Febbre" dedicato ai pazienti con sintomi influenzali:

Pronto Soccorso DEA di II livello - viale del Policlinico 155 sede di– Edif.4
Pronto Soccorso Ematologico – via Benevento 7, Edif. 46a
Pronto Soccorso Oculistico - Pronto Soccorso Odontoiatrico - viale Regina Elena 287/b - Presidio G.Eastman, Edif.62
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico – via G.M. Lancisi 2, Edif. 35
Pronto Soccorso Pediatrico - viale Regina Elena 324, Edif. 37
Pronto soccorso - Policlinico Umberto 1

RICOVERO

La principale attività aziendale è costituita dal ricovero istituzionale. Il ricovero è un periodo di permanenza in Ospedale necessario alla valutazione dello stato di salute o per ricevere cure.
URGENTE avviene tramite accesso autonomo, con mezzi di soccorso, con richiesta del Medico di Medicina Generale, Guardia Medica, Specialista. Il Medico di Pronto Soccorso effettuerà le valutazioni avvalendosi, ove necessario, anche di consulenze specialistiche. Il ricovero potrà avvenire anche con accesso diretto in reparto se le condizioni lo richiedessero.
PROGRAMMATO può essere attivato su proposta del Medico di Medicina Generale o da uno Specialista interno a seguito di una visita ambulatoriale o da uno Specialista esterno alla struttura ospedaliera. In alcuni casi può essere preceduto dalla pre-ospedalizzazione. Al fine di abbreviare la degenza ospedaliera, i Medici Specialisti dell'AOU PUI possono indirizzare i cittadini in pre-ospedalizzazione per visite ed accertamenti diagnostici finalizzati all'intervento chirurgico. Gli accertamenti diagnostici seguiti dall'intervento chirurgico, non sono soggetti al pagamento del relativo ticket. Per tutti i ricoveri programmati le Regioni e Province Autonome prevedono l'uso sistematico delle Classi di priorità, definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito dell'Accordo dell'11 luglio 2002 e del PNCTA 2006-2008 e del PNGLA 2010-2012.
DAY HOSPITAL è un ricovero giornaliero programmato effettuato in un'unica giornata o in cicli con accessi di più giornate durante le quali vengono erogate le prestazioni programmate (non è necessario pertanto che il paziente pernotti in ospedale). È' rivolto ai pazienti che necessitano di prestazioni multi professionali e plurispecialistiche di particolare complessità; l'accesso al Day Hospital avviene attraverso una visita di selezione ambulatoriale oppure su indicazione del medico di base.
DAY SURGERY è un ricovero giornaliero programmato effettuato per consentire interventi chirurgici minori, con dimissione il pomeriggio stesso del giorno di intervento o il giorno seguente.
Il ricovero può avvenire solo in modo programmato da parte del medico proponente che provvede ad inserire il paziente in una lista di attesa

NORME COMPORTAMENTALI E IGIENICO SANITARIE PER L'ACCESSO DI VISITATORI E CAREGIVER PRESSO I REPARTI DI DEGENZA E PRECAUZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
Per il ricovero al Policlinico Umberto I è necessario portare:

- documenti
- effetti personali per l'igiene (pigiami, biancheria intima, asciugamani, pantofole antiscivolo)
- per i famigliari di ciascun paziente il Direttore di Unità Operativa organizza l'attività in modo da garantire la presenza di un medico strutturato, negli orari di ricevimento che ciascuna struttura affiggerà all'ingresso del reparto.
- Per informazioni specifiche sulle prestazioni, i pazienti devono consultare il sito web aziendale nelle sezione Dipartimenti Assistenziali Integrati/Unità Operative o contattare direttamente le strutture cliniche per dettagli su ricoveri ordinari e diurni (day hospital).

Informazioni ai pazienti e familiari/caregivers per ricovero programmato e prestazioni - Policlinico Umberto 1

DIMISSIONE PROTETTA

La dimissione protetta è una modalità con la quale si tutela un paziente che viene dimesso. In particolari casi è prevista la possibilità di eseguire tali prestazioni dopo l'avvenuta dimissione, utilizzando la stessa cartella clinica, senza dover effettuare un nuovo ricovero.
La dimissione protetta è una modalità con la quale si tutela un paziente che viene dimesso:

- è disposta dal Medico del Reparto, che provvederà a segnalare al paziente la data di esecuzione dell'esame o della specifica prestazione;
- si attiva all'atto dell'ingresso in ospedale o durante la degenza, qualora il paziente e/o familiari Informano il personale della difficoltà di rientrare al proprio domicilio;
- si attiva dopo aver effettuato una serie di valutazioni sociosanitarie sui bisogni del paziente una volta rientrato

a domicilio; in alcuni casi potrebbero essere coinvolti il Medico di Medicina generale, il servizio di assistenza domiciliare, i Servizi Sociali del Comune.
La Dimissione Protetta introduce una sospensione del ricovero iniziale atta a consentire il completamento dello stesso, con l'effettuazione delle sole procedure diagnostiche e terapeutiche ad esso collegate. Tale periodo, la cui durata massima è di 30 giorni, è parte integrante del ricovero e, pertanto, tutti gli esami eseguiti in questo regime, collegati all'episodio di ricovero, non prevedono il pagamento di alcun ticket.

L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)

L'attività libero-professionale intramuraria si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai Dirigenti Medici e Sanitari dell'Azienda, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'Azienda stessa a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I attua l'istituto dell'attività libero professionale intramoenia secondo le indicazioni dettate dalla normativa.
Modalità di accesso: ReCup 06 9939 (dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 7:30 alle 13:00)
Contatti: 06 49977000
Orario: lunedì - venerdì dalle 14:00 alle 17:30

BOLLINO ROSA

Il Policlinico Umberto I di Roma si è aggiudicato da diversi anni tre Bollini Rosa, confermandosi Ospedale "amico delle donne". Il massimo riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie femminili è stato conferito dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) che dal 2007 attribuisce uno, due o tre Bollini Rosa alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Tre i criteri di valutazione per l'attribuzione dei Bollini: la presenza, all'interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, l'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l'offerta di prestazioni aggiuntive legate all'accoglienza e alla presa in carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.

BOLLINO AZZURRO

Nella cerimonia di presentazione della seconda edizione del Bollino Azzurro che si è tenuta il 16 gennaio 2025, a Milano presso la Sala Pirelli della Regione Lombardia, il Policlinico Umberto I ha ricevuto da Fondazione Onda ETS la prestigiosa attestazione del Bollino Azzurro 2025, un riconoscimento attribuito per la presenza nell'ospedale di percorsi di promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e ulteriori servizi volti a garantire un'adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.
Il Policlinico Umberto I viene annoverato tra i 156 ospedali che in Italia hanno ricevuto da Fondazione Onda ETS l'attestazione nel quadro della seconda edizione del Bollino Azzurro, volta ad individuare i centri, partendo dal network di ospedali con il Bollino Rosa, virtuosi per l'offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche.
Nell'ambito dell'iniziativa, gli obiettivi sono: migliorare l'accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un'informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

ASPETTI ALBERGHIERI E COMFORT

Servizio spirituale
Nel PUI l'assistenza spirituale religiosa di culto cattolico è assicurata nel rispetto di ogni idea, fede e

convinzione dalla comunità ecclesiale che si rende disponibile a far visita ai degenti, nei reparti, a rispondere alle richieste di aiuto spirituale o religioso, al colloquio, all'ascolto e all'amministrazione dei Sacramenti.
Sede: Edif.24a, primo piano
Orario: disponibilità h24
Contatti: 06 49973588
Bar interno
Sede: fronte Edif.26/34
Orario: lunedì - venerdì dalle ore 6.00 alle ore 15.30
Bar presidio George Eastman
Sede: Edif.62 viale R. Elena 287/b, piano seminterrato
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.30
Contatti: 06 49976088
Distributori Automatici
Al fine di consentire a pazienti, visitatori ed operatori di poter usufruire di generi di ristoro e cura della persona, in diversi punti dell'ospedale sono ubicati distributori automatici.
Banca
All'interno del PUI è presente UNICREDIT BANCA con l'AGENZIA di ROMA POLICLINICO UMBERTO I - Viale Del Policlinico 155 - 00161 Roma (RM), che offre il servizio di Sportello Automatico abilitato alla firma elettronica.
E' presente sportello Bancomat.
Sede: Edif.30
Orario: lunedì - venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 15.45.
Contatti: 06 87824304

COSA FARE PER

AVERE INFORMAZIONI

Centralino aziendale digitale, consente al cittadino di mettersi in contatto con tutti i servizi aziendali
Orario: h 24
Contatti: 06 4997

APP POLICLINICO UMBERTO I

Un nuovo servizio per i pazienti dedicato non solo all'orientamento all'interno del Policlinico Umberto I di Roma (una mappa/Google Maps indicherà il percorso più veloce per accedere alla tua prestazione/destinazione (ambulatori, reparti, casse, etc.), perché con la con l'applicazione puoi consultare i tuoi appuntamenti, richiedere la cartella clinica, trovare la sede e prenotare la tua donazione di sangue.
L'APP del Policlinico Umberto I è scaricabile dagli store Android e iOS, mediante la APP Policlinico Umberto I è possibile eseguire il self check-in e il pagamento delle prestazioni ambulatoriali prenotate tramite Recup senza dover passare alle casse ticket.
Scaricala qui per Android: bit.ly/4132Zxt
Scaricala qui per iOS: bit.ly/4gtWtnR
Scarica subito la APP Policlinico Umberto I - Policlinico Umberto 1

URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

E' un servizio di ascolto attivo a disposizione

dell'utenza. Comunicazione-URP e Ufficio Stampa - Policlinico Umberto 1
Sede: Edif.4
Orario: dal lunedì – giovedì, 8.00-14.00 e 14.30-17.30; venerdì 8.00-14.00
Contatti: 0649977050/4
e-mail: urp@policlinicoumberto1.it

SEGNALARE RECLAMI, DISSERVIZI, ENCOMI

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è lo strumento con il quale il cittadino diviene parte attiva attraverso la comunicazione con segnalazione di criticità o proposte. Sul sito aziendale www.policlinicoumberto1.it - sezione Urp - è a disposizione dell'utenza la modulistica per segnalazioni, delega. Si ricorda che in caso di delega è necessario presentare/allegare delega e copia del documento d'identità del delegante e del delegato. Per encomi/segnalazioni/reclami scrivere a: ufficioprotocollo@policlinicoumberto1.it
Accoglienza del Dipartimento Emergenza e Accettazione, Aree Critiche e Trauma. E' un servizio di ascolto, informazione e sostegno dedicato all'accoglienza dei pazienti e dei familiari che accedono al Pronto Soccorso.
Sede: Edif.4, piano terra
Orario: h24
Contatti: 06 49977025/7

UFFICIO STRANIERI

E' un servizio aperto al pubblico che offre assistenza ai cittadini stranieri - Unione Europea e assistenza Cittadini di Paesi con accordi bilaterali per accedere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.
Sede: Edif.15 (III Padiglione), piano terra, stanza 4
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e lunedì - giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Contatti: 06 49970348 – 06491842
e-mail: uffstran@policlinicoumberto1.it
Ufficio Stranieri - Policlinico Umberto 1

RILASCIO PERMESSI VEICOLI - MOBILITY MANAGER/MOBILITÀ

Sede: edif.25 – 1° piano (ingresso di seguito il cup/cassa ticket)
Contatti: Mobility Manager/Mobilità Rilascio permessi veicoli - Policlinico Umberto 1
Attività: rilascio permessi veicoli, è possibile richiedere i permessi per ingresso e sosta :
pazienti in trattamento diagnostico-terapeutico ditte e fornitori

PRENOTAZIONI

L'utente per prenotare visite, esami diagnostici e specialistici, deve essere in possesso della prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista del SSR e della tessera TEAM (la tessera sanitaria che contiene il codice fiscale). L'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte del cittadino avviene di norma sulla base di criteri di priorità clinica indicati dal Medico sulla ricetta, secondo quanto codificato dalla normativa in vigore e sull'appropriatezza delle indicazioni alla prestazione. La prescrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte – comprensiva quindi anche di eventuali esenzioni alla compartecipazione alla spesa.
La prenotazione della prestazione sanitaria potrà avvenire attraverso:
RECUP Regionale – 069939 - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00
RECUP - Prenota smart al seguente link: https://www.salutelazio.it/recup-prenota-smart

***"Progetto per il benessere e la salute della donna"* sono svolte presso "Palazzo Baleani" (III Piano- Corso**

Vittorio Emanuele II , 244 - 00186 Roma III Piano)

Tale Progetto ha come obiettivo principale la cura delle donne di ogni età con percorsi terapeutici mirati e trattamenti specifici. A tal fine il Progetto coinvolge e coordina specialisti e servizi di diverse discipline per offrire percorsi integrati e multidisciplinari dedicati alla salute e al benessere della donna nei diversi momenti della sua vita. Il Progetto non solo garantisce la presa in carico dei bisogni di salute ma si impegna, altresì, a promuovere stili di vita sani e condivisi con percorsi di sensibilizzazione sui possibili rischi connessi alla crescita e all'età.
Come Centro di riferimento il centro per la salute delle donne promuove attività di counselling con bilanci di salute personalizzati per le donne in qualsiasi momento della loro vita. Tali attività si propongono come complementari a quanto già previsto in termini di prevenzione nei servizi territoriali. Oltre a favorire un accesso facilitato a percorsi di cura già predefiniti, il Centro risponde alla necessità di valutazione complessiva dei bisogni di salute della donna con un approccio olistico e competenze specialistiche relative alla medicina di genere. L'intercettazione del bisogno della donna all'interno degli ambulatori del Centro favorisce l'accesso ai percorsi di presa in carico e gestione clinico-assistenziale già definiti all'interno dell'azienda e nell'ambito della rete regionale.

Pagamenti e registrazioni ticket - pagamenti e registrazioni ticket - policlinico umberto 1

L'utente che deve versare le somme dovute per

1. partecipazione obbligatoria alla spesa (ticket) per le prestazioni sanitarie del SSR
2. partecipazione obbligatoria alla spesa (ticket) per le prestazioni di pronto soccorso
3. prestazioni sanitarie rese a soggetti privati paganti
4. rilascio di cartelle cliniche, atti e duplicazione lastre/cd/dvd

potrà eseguire il pagamento mediante contanti, POS e carte di credito, ovvero, direttamente all'Azienda mediante pagamenti elettronici pagoPA e, per le prestazioni ambulatoriali, sia in regime istituzionale che in regime intramoenia, prenotate tramite RECUP è possibile effettuare il pagamento tramite App evitando la fila alle casse ticket non solo per il self check-in (utenti esenti) ma anche per il pagamento (utenti solventi).

L'APP del Policlinico Umberto I

Scaricala qui per Android: bit.ly/4132Zxt
Scaricala qui per iOS: bit.ly/4gtWtnR

L'utente esente per patologia ed invalidità civile può accedere direttamente agli ambulatori senza recarsi alle casse aziendali munito di impegnativa del medico curante, codice di esenzione e tessera sanitaria.
Solo per le prestazioni radiologiche e i prelievi ematici, è necessario rivolgersi alle casse aziendali.
Con l'applicazione puoi consultare i tuoi appuntamenti, richiedere la cartella clinica, trovare la sede e prenotare la tua donazione di sangue.

RICHIEDERE/RITIRARE LA CARTELLA CLINICA

La Cartella clinica contiene dati personali "ex*sensibili"* che godono della massima tutela e pertanto, può essere richiesta *di persona* oppure *on-line* dall'interessato o da un suo delegato, o da persona autorizzata dalla legge (erede legittimo, erede testamentario, legale rappresentante, tutore, curatore, amministratore di sostegno di persona non in possesso di capacità di agire) compilando apposita modulistica scaricabile dal sito aziendale.

Cartella clinica e documentazione sanitaria - Policlinico Umberto 1
Dove richiederla

All' Ufficio – Servizio Aziendale Cartella Clinica (SACC), presso Edif. 16 (IV Padiglione), piano terra.
Orario di apertura:

dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (ultimo accesso ore 12.30)
martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00 (ultimo accesso ore 16.30)
o secondo gli orari diversamente comunicati all'utenza.

Come richiederla

di persona presso lo sportello a pagamento
on-line gratuitamente con SPID e CIE accedendo a: https://cds.policlinicoumberto1.it/
Chi può richiederla
titolare della documentazione, se maggiorenne
delegato del titolare presentando allo sportello il modulo di delega completo del documento di identità e debitamente compilato in ogni sua parte
esercente la responsabilità genitoriale su minore, tutore, curatore, amministratore di sostegno di persona non in possesso della capacità di agire presentando allo sportello l'apposito modulo di richiesta minore debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dei documenti richiesti
erede legittimo o erede testamentario con modulo paziente deceduto attestante la relazione di parentela o nomina di erede da parte del defunto comprensivo della Dichiarazione sostitutiva.

Tariffe ricovero ordinario o day hospital	CARTACEO	ONLINE /SPID e/o CIE
Fino a 250 pagine e senza immagini	€ 20,00	
Supplemento oltre le 250 pagine	€ 5,00	GRATUITA

Il legale rappresentante munito di idoneo mandato o procura.

Contatti:

email a richiestacartellaclinica@policlinicoumberto1.it per assistenza e/o comunicazioni.
Documentazione sanitaria DEA
Richiesta/rilascio duplicazione immagini afferenti alle Unità Operative del Dipartimento Emergenza Accettazione, Aree Critiche e Trauma.
Sede Edif.4, piano terra

Orario Giorni Lunedì e Mercoledì
mattina 08.00 – 12.00
pomeriggio 14.00 – 16.00
Orario Giorni Martedì, giovedì e Venerdì
mattina 08.00 – 12.30
Recapito 0649979592
e-mail (per eventuali richieste):
archivio.radiologiadea@policlinicoumberto1.it

Tariffa duplicazione immagini:

Il pagamento dei costi di riproduzione viene effettuato al momento della richiesta.
Il costo di riproduzione della documentazione sanitaria, è cosi individuato:
Duplicazione immagini, nr. 1 copia su CD euro 15,00
Consultazione, stampa e ritiro on line dei referti degli esami di radiologia
Per visualizzare, salvare e stampare i propri referti di Radiologia: Rx, Mammografie, Ecografie, Tomografie Computerizzata (TAC) e Risonanza Magnetica direttamente dal computer di casa.
Approfondimenti al seguente link: https://www.policlinicoumberto1.it/unita/radiologia/

DICHIARARE LA NASCITA

La dichiarazione della nascita può essere resa presso l'Ufficiale di stato civile, del luogo dove si è verificato l'evento oppure nel Comune di residenza dei genitori.
La registrazione deve essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, può essere resa presso il Centro Nascite entro tre giorni presso l'ospedale/casa di cura di nascita R.D. n. 1238/1939 – D.P.R. n. 396/2000.
Centro Nascite
Sede: Edif. 35, piano terra stanza 45
Orario: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30

DONARE SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Per prenotare il giorno e l'ora della donazione, contattare il Servizio trasfusionale e/o le Associazioni Donatori di riferimento consultabili al link: APP Policlinico Umberto I….Prenota la tua donazione
Dona il tuo sangue - Policlinico Umberto 1
Contatti Policlinico Umberto I
Centro trasfusionale – Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Accettazione donatori dalle ore 07.30 – 12.00
Contatti: 0649976417 – 0649976418
Per informazioni:

Ambulatorio PBM (Patient blood Management)
06 49976411
Coordinatore Infermieristico:
06 49976410
Distribuzione interna emocomponenti H24

AD SPEM
Segreteria 07.30 – 16.00
Viale del Policlinico, 155
00161 Roma
Contatti: 0649976414 – 0649976415 – 0649976427
adspem@policlinicoumberto1.it

ADMO Lazio Sede dedicata a Francesco Saverio More

Viale del Policlinico 155
00161 Roma
Contatti: 3335677430 – 3509627170
info@admolazio.it
roma@admolazio.it

AVIS – Via Imperia, 2
00161 Roma
contatti: 0644230134
Info@avisroma.it

IMPEGNI E STANDARD QUALITA'

STANDARD DI QUALITA'

Questa sezione rappresenta gli impegni assunti dall'Azienda nei confronti dei cittadini.
L'andamento e la verifica degli impegni assunti sono tenuti sotto monitoraggio mediante l'impiego di indicatori che permettono di misurare e registrare il raggiungimento o meno dei risultati attesi.
Gli impegni e gli standard si riferiscono alle seguenti categorie:
Aspetti relazionali
Informazione e comunicazione
Umanizzazione
Tempi e accessibilità
Tutela e ascolto
Aspetti alberghieri e comfort
Servizi in rete/amministrazione Trasparente

ASPETTI RELAZIONALI

Impegno	**Indicatore**	**Standard**	**Valutazione**
Garantire il miglioramento dei rapporti relazionali tra il paziente, i suoi famigliari ed il personale	N. di reclami su aspetti relazionali/N. tot. dei reclami	Decremento % dei reclami per gli aspetti relazionali	Monitoraggio reclami
Riconoscibilità del personale	N. dipendenti che esibiscono il cartellino di identificazione /N. tot. di dipendenti	100%	Valutazione sul campo

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Impegno	Indicatore	Standard	Valutazione
Garantire informazioni ai cittadini sui servizi offerti tramite il sito web aziendale/ Carta dei Servizi digitale	Carta dei servizi digitale Scheda informativa per il ricovero ospedaliero	Decremento % dei reclami per gli aspetti relazionali 100%	Monitoraggio reclami Valutazione sul campo
Garantire al paziente l'informazione sulle procedure cliniche che necessitano di consenso informato	Presenza nella documentazione sanitaria del consenso informato	100%	Valutazione Cartelle Cliniche

UMANIZZAZIONE

Impegno	Indicatore	Standard	Valutazione
Garantire la valutazione e il trattamento del dolore nelle U.O.	Presenza di linee guida/protocolli operativi/procedure per la gestione del dolore Presenza della registrazione della valutazione del dolore nella documentazione sanitaria	>90% 100%	Monitoraggio attraverso VAS (scala valutazione del dolore) Cartella Clinica infermieristica
Garantire il rispetto della privacy durante i colloqui con il paziente e/o i familiari	% di reparti in cui È presente la comunicazione per l'orario , le modalità di ricevimento e colloquio familiari	100%	Valutazione sul campo

TEMPI E ACCESSIBILITA'

Impegno	Indicatore	Standard	Valutazione
Accesso alle prestazioni (prime visite ed esami diagnostici). Monitorare il rispetto dei tempi massimi individuati dalla normativa regionale vigente	N. prestazioni richieste/N.tot. prestazioni erogate nei tempi definiti dalla normative della Regione Lazio	>90%	Dati da sito web istituzionale www.regionelazio.it
Accesso al ricovero ospedaliero programmato Monitorare il rispetto dei tempi di attesa individuati dalla normativa regionale vigente	**Classe A**: % casi trattati entro 30 gg. **Classe B**: % casi trattati entro 60 gg. **Classe C**: % casi trattati entro 180 gg. **Classe D**: % casi trattati entro 365 gg.	Aderenza agli standard regionali per classe di priorità	Dati da sito web istituzionale www.regionelazio.it Monitoraggio tempi di attesa prestazioni erogate in regime di ricovero (Amministrazionetrasparente/ Servizi erogati sito web istituzionale www.policlinicoumberto1.it) Monitoraggio
Garantire il rispetto dei tempi per il rilascio della Documentazione Sanitaria	N. copie di Cartelle Cliniche rilasciate entro 30 gg. dal momento della richiesta/N.tot. de richieste	>90%	Monitoraggio

TUTELA E ASCOLTO

Impegno	Indicatore	Standard	Valutazione
Garantire ai cittadini che hanno presentato un reclamo la risposta finale entro 30 gg., salvo i casi che presentano caratteristiche di complessità	N. reclami risposti entro 30 gg./N. tot. reclami	100%	Monitoraggio reclami

Diritto alla protezione dei dati personali. Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, pratiche amministrative deve essere garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.	N. richieste eseguite/N. tot. richieste	100%	Monitoraggio e verifica

ASPETTI ALBERGHIERI E COMFORT

Impegno	Indicatore	Standard	Valutazione
Curare il comfort aree comuni	Presenza bar/distributori automatici alimenti, bevande e cura della persona	100%	Valutazione sul campo
Garantire per ogni tipologia di dieta maggiore possibilità di scelta nel menù	Richiesta giornaliera delle preferenze dei pazienti nei vari reparti su menu' fisso, ma con più possibilità di scelta	100% dei reparti	Reclami Monitoraggio

PROTEZIONE DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il diritto comunitario a protezione dei dati del cittadino europeo

Il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno approvato il *"General Data Protection Regulation"*, in italiano "Regolamento Generale per la protezione dei dati", UE/2016/679 (GDPR).
Il GDPR è entrato in vigore, contemporaneamente in tutti i 28 Paesi aderenti all'Unione, il 24 maggio 2016 e ha trovato piena attuazione a far data dal 25 maggio 2018.
Il GDPR ha stabilito norme relative alla protezione dei dati delle persone fisiche nel momento in cui questi sono trattati (raccolti, utilizzati, conservati, trasmessi) e ne ha regolamentato la libera circolazione all'interno della UE, nell'intento di proteggere i diritti e le libertà fondamentali della persona.
Una particolare attenzione è stata rivolta ai dati richiesti all'assistito nel momento in cui necessita di servizi di diagnosi, cura o assistenza sociale poiché una inadeguata protezione di tali dati, una raccolta con modalità inadeguate o una utilizzazione non pertinente alle reali necessità informative, possono provocare danni irreparabili per la dignità della persona e per il suo diritto all'autodeterminazione e alla riservatezza.
Di seguito si forniscono le *Informazioni* circa le modalità con cui i dati degli utenti, e degli altri soggetti interessati, sono trattati all'interno del Policlinico Umberto I.

Il Policlinico e la protezione dei dati dei suoi assistiti

Il Policlinico Umberto I, in qualità di *Titolare del Trattamento dei dati personali*, garantisce che il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sia effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, assicurando la riservatezza e la sicurezza delle informazioni nel presupposto che identità fisica e identità digitale godano degli stessi diritti e debbano essere protette da adeguate ed idonee misure di rispetto e di protezione.
Tali princìpi trovano particolare fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana.
Il trattamento dei dati personali da parte del Policlinico, improntato a principi di correttezza, liceità e legittimità, riserva una particolare attenzione a che ogni azione sui dati da parte del personale dell'ospedale non vada mai oltre le finalità per le quali è necessario che gli stessi dati siano raccolti.
Infine, si informa che, per consentire un'adeguata responsabilizzazione delle figure apicali dell'ospedale e una maggiore attenzione ai processi operativi riguardanti i dati degli assistiti, il Policlinico ha nominato la nuova figura prevista dal GDPR, il "Data Protection Officer" (DPO), ed ha adottato un sistema di delega di funzioni che coinvolga livelli decisionali e operativi più prossimi alla produzione di servizi, provvedendo inoltre ad autorizzare il proprio personale al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati del Policlinico

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria *Policlinico Umberto I*
Contatti del Titolare del trattamento:
email: **ufficioprotocollo@policlinicoumberto1.it**
PEC: **protocollo@pec.policlinicoumberto1.it**

I Delegati per la protezione dei dati dell'Azienda Policlinico

Vista la complessità dell'ospedale e delle attività che vi si svolgono, il Titolare del trattamento ha attribuito specifiche deleghe di funzioni che consentano la necessaria prossimità alle funzioni

produttive, una maggiore responsabilizzazione delle stesse, un migliore indirizzamento degli operatori e un'adeguata vigilanza sui processi, sulle procedure e sull'utilizzazione degli strumenti autorizzati per il trattamento dei dati.
DELEGATI PRIVACY

Il personale autorizzato, incaricato del trattamento dei dati del Policlinico

Coloro che operano nell'ospedale nei diversi ruoli professionali (dipendenti, in formazione, fornitori di servizi, volontari di associazioni) sono stati autorizzati ad esercitare uno specifico ruolo operativo e incaricati di attuare i processi previsti e di trattare i dati degli assistiti utilizzando le forme e gli strumenti specificamente autorizzati.
Tutti gli incaricati ricevono, dal rispettivo Delegato per la protezione dei dati, specifiche informazioni ed istruzioni circa le procedure, le funzioni, le modalità, le responsabilità e gli strumenti utilizzati.
Il Data Protection Officer (DPO) del Policlinico
Come previsto dall'art. 37 del Regolamento europeo, il Policlinico ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO) o "Responsabile della Protezione dei dati" (RPD) nella persona dell'Avv. *Isabella Lucati*.
Come previsto dall'art. 39 del GDPR il DPO ha il compito di:
informare e fornire consulenza al Titolare e ai suoi Delegati in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, dal Codice per la protezione dei dati personali e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;
fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata dalle funzioni operative dell'ospedale e sorvegliarne lo svolgimento;
cooperare con l'Autorità di controllo;
fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo.
Contatti del DPO:
email: responsabileprotezionedati@policlinicoumberto1.it
Quali sono le principali norme di riferimento in materia di trattamento e protezione dei dati?
Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) – GDPR – Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e Consiglio d'Europa, 27aprile 2016
Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) – Regolamento UE/2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014
Linee guida in materia di Dossier Sanitario Elettronico – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 4 giugno 2015, n. 331
Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico – DPCM 29 settembre 2015, n. 178
Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro – Autorizzazione generale n. 1/2016 – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n. 523

- Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – Autorizzazione generale n. 2/2016 – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n. 524
- Trattamento dei dati genetici – Autorizzazione generale n. 8/2016 – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n. 530
- Trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica – Autorizzazione generale n. 9/2016 – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n. 531

- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 18 dicembre 2018, n. 515

Informazioni sul trattamento dei dati personali
INFORMAZIONI FORNITORI ED ENTI IN CONVENZIONE
INFORMAZIONI AGLI UTENTI